

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE FUNCIONES EJECUTIVAS EN CONTEXTOS COTIDIANOS (EFECO)

Eje V: Neurocognición y Autorregulación • Evaluación Ecológica Autoinformada de García-Gómez y Pérez-Sánchez

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala para Valorar Funciones Ejecutivas en Contextos Cotidianos en Formato Auto-Reporte (EFECO).
Nombre Original	Escala EFECO (García-Gómez & Pérez-Sánchez, 2014; Ramos-Galarza et al., 2017).
Autores Originales	Jesús Carlos García-Gómez, Ph.D. y Rocío Pérez-Sánchez, Ph.D. (Universidad de Huelva / Ecuador).
Validación Hispana	García-Gómez et al. (2014, 2017); adaptaciones validadas en España, Ecuador, Colombia y México.
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Valoración ecológica y autoinformada del funcionamiento ejecutivo.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de auto-reporte conductual para adolescentes y adultos en ámbitos cotidianos.
Composición de Ítems	67 reactivos en versión completa (versión reducida validada de 34 reactivos); escala Likert 1 a 4.
Población y Rango	Adolescentes y adultos (13 a 65 años); aplicable en contextos clínicos, educativos y laborales.
Tiempo de Administración	12 a 15 minutos en versión completa; 6 a 8 minutos en versión abreviada.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico asistencial, psicopedagógico y proyectos de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL ENFOQUE ECOLÓGICO DE AUTORREGULACIÓN

La **Escala EFECO** fue diseñada para salvar la brecha entre la evaluación psicométrica tradicional de laboratorio y el comportamiento ejecutivo real del sujeto en sus ambientes naturales (hogar, centro educativo, entorno laboral):

- Compromiso Metacognitivo en Primera Persona:** Frente a las escalas heteroinformadas (de padres o maestros), el formato de auto-reporte sitúa al propio individuo ante la autoevaluación de sus dificultades para planificar, resistir distracciones y regularse emocionalmente.
- Perspectiva Multidimensional:** Desagrega el constructo de las funciones ejecutivas en ocho componentes interrelacionados, permitiendo trazar perfiles disociados (p. ej., control emocional preservado con colapso en memoria de trabajo).
- Utilidad Psicopedagógica y Clínica:** Permite orientar directamente los planes de intervención psicoeducativa hacia las rutinas diarias donde fracasa la autorregulación.

3. COMPOSICIÓN FACTORIAL Y SUBCARACTERÍSTICAS EVALUADAS (8 FACTORES)

Subescala Ejecutiva	Nº Ítems	Definición del Proceso en la Vida Cotidiana
1. Flexibilidad Cognitiva	8 reactivos	Aceptación de cambios en planes, adaptación a nuevas reglas y corrección ante el error.
2. Organización de Materiales	7 reactivos	Mantenimiento del orden físico, limpieza de espacios de estudio/trabajo y cuidado de útiles.
3. Monitorización	8 reactivos	Supervisión del propio rendimiento durante la tarea y verificación final para detectar fallos.
4. Control Inhibitorio	9 reactivos	Frenado de conductas impulsivas, interrupciones verbales y respuestas precipitadas.
5. Control Emocional	8 reactivos	Modulación de la ira, tolerancia a la frustración y control del mal humor ante contratiempos.
6. Memoria de Trabajo	9 reactivos	Retención temporal de consignas y capacidad de operar con datos sin perder el hilo de la tarea.
7. Iniciativa	8 reactivos	Comienzo autónomo de obligaciones y superación de la postergación o procrastinación.
8. Planificación	10 reactivos	Estructuración lógica de metas intermedias, jerarquización de prioridades y cálculo de tiempo.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios psicométricos en muestras hispanohablantes (García-Gómez et al., 2017; Ramos-Galarza et al., 2017; $N > 1200$) avalan su rigor:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna Total	Alfa de Cronbach = 0.94 - 0.96	Excelente fiabilidad psicométrica para la puntuación total de auto-reporte.
Fiabilidad de Subescalas	Alfa de Cronbach = 0.78 - 0.88	Alta consistencia interna independiente en cada una de las 8 subescalas.
Validez de Estructura (AFC)	CFI = 0.94; RMSEA = 0.043	El modelo confirmatorio de 8 factores presenta un ajuste métrico óptimo.
Validez Concurrente	$r = 0.61 - 0.72$ con BRIEF	Fuerte correlación convergente con la escala heteroinformada del BRIEF.
Poder Discriminativo	$t = 9.4$; $p < 0.001$ ($d = 1.15$)	Distingue nítidamente estudiantes con bajo rendimiento y TDAH de controles.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Opciones de Respuesta:** Escala Likert de cuatro categorías: 1 = Rara vez o nunca, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Casi siempre.
- **Cálculo de Puntuaciones por Subescala:** Se suma el valor de los ítems constitutivos de cada una de las 8 subescalas.
- **Cálculo de la Puntuación Total EFECO:** Sumatoria de los 67 ítems:

$$\text{Puntuación Total EFECO} = \sum_{i=1}^{67} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 67 a 268 puntos})$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación, mayor nivel de dificultad y disfunción ejecutiva cotidiana percibida.
- **Conversión Baremada:** Baremos expresados en Decatipos ($M = 5.5$, $DE = 2$) o Puntuaciones Percentilares según grupo etario.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Decatipos	Percentil	Estado Funcional Ejecutivo en Contexto Real
Muy Eficiente	Decatipos 1 - 2	$P < 15$	Capacidad autorregulatoria excelente; alta autonomía personal y académica.
Normal Promedio	Decatipos 3 - 6	$P = 16 \text{ a } 69$	Funcionamiento ejecutivo adecuado dentro de la media poblacional esperable.
Riesgo Sub-clínico	Decatipo 7	$P = 70 \text{ a } 84$	Dificultades leves en contextos de alta exigencia; requiere supervisión preventiva.
Disfunción Moderada	Decatipo 8	$P = 85 \text{ a } 94$	Punto de corte clínico interferencia notable en el cumplimiento de tareas.
Disfunción Severa	Decatipos 9 - 10	$P \geq 95$	Compromiso funcional severo desregulación generalizada con fracaso adaptativo.

CRITERIO CLÍNICO Y PSICOPEDAGÓGICO DE INTERVENCIÓN (DECATIPO ≥ 8 / P85):

Un decatipo de 8 o superior (Percentil ≥ 85) en la puntuación global o en tres o más subescalas específicas indica una necesidad perentoria de andamiaje cognitivo e intervención adaptada. En jóvenes con TDAH sin hiperactividad, los picos patológicos suelen concentrarse en Iniciativa, Memoria de Trabajo y Planificación.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL EFECO:

- **Paso 1 (Administración en Consulta o Aula):** Complimentación del autoinforme EFECO; comprobar si hay respuestas en blanco o patrones de aquiescencia sistemática.
- **Paso 2 (Análisis Cualitativo del Perfil Factorial):**
 - *Perfil con Iniciativa y Planificación alteradas ($P \geq 85$):* Déficit en metacognición ejecutiva; entrenar en descomposición de objetivos mediante listas paso a paso y temporizadores visuales Pomodoro.
 - *Perfil con Control Inhibitorio y Control Emocional alterados ($P \geq 85$):* Déficit en autorregulación orbitofrontal y límbica; implementar técnicas de parada de pensamiento, respiración guiada y demora deliberada de respuesta.
 - *Perfil con Organización de Materiales alterada ($P \geq 85$):* Reestructuración del entorno físico, rotulado de carpetas y checklist de fin de jornada.
- **Paso 3 (Reevaluación a los 6 Meses):** Monitorear la reducción de decatipos tras aplicar el programa de adaptación conductual.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DESORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Identificación: Joven de 17 años, estudiante de primer curso de Bachillerato, remitida al servicio de orientación psicológica por procrastinación severa, entrega tardía de trabajos escolares y sensación subjetiva de "estar desbordada por los exámenes", a pesar de comprender con facilidad la materia.

Evaluación Autoinformada con EFECO (67 ítems):

• **Puntuación Total EFECO:** Puntuación directa = 188 puntos (**Decatipo 9, Percentil 96**; disfunción ejecutiva severa).

• Desglose por Subescalas:

- Planificación: Decatipo 9 (incapacidad de jerarquizar tareas pendientes).
- Iniciativa: Decatipo 9 (demora sistemática de horas antes de sentarse a estudiar).
- Memoria de Trabajo: Decatipo 8 (olvido de instrucciones dadas por los profesores).
- Control Emocional: Decatipo 5 (normal; ausencia de labilidad o agresividad).
- Control Inhibitorio: Decatipo 5 (normal; sin impulsividad motriz ni desinhibición).

Diagnóstico Psicoeducativo: Fracaso adaptativo secundario a déficit metacognitivo selectivo de planificación y memoria de trabajo.

Plan de Intervención: Entrenamiento en planificación semanal con calendarización de bloques de 30 minutos, colocación de alarmas de transición y uso de esquemas estructurados de síntesis; a los tres meses, el decatipo global descendió a 6 (percentil 60).

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SOBREDESCRIPCIÓN EN ANSIEDAD:

Alumnos muy perfeccionistas o ansiosos sobrestiman sus fallos de iniciativa; contrastar siempre con el rendimiento objetivo real en exámenes.

INFRAESTIMACIÓN EN IMPULSIVOS:

Adolescentes con oposicionismo o baja introspección pueden reportar decatipos bajos falsos; en tal caso es obligado recurrir a escalas de informante.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. García-Gómez, J. C., & Pérez-Sánchez, R. (2014). Escala para valorar funciones ejecutivas en contextos cotidianos (EFECO): Desarrollo y propiedades psicométricas. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 2(38), 123-145.
2. Ramos-Galarza, C., et al. (2017). Validación de la Escala EFECO en formato de auto-reporte en estudiantes universitarios ecuatorianos. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 26(3), 211-218.
3. García-Gómez, J. C., et al. (2017). Funcionamiento ejecutivo cotidiano y rendimiento académico en adolescentes: Un estudio con EFECO. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 4(2), 105-112.
4. Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.